



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA PONEK
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
OKTOBER 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LAPORAN KINERJA PONEK BULAN OKTOBER 2025

RS PRIMA HUSADA MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN) masih menjadi tantangan besar, di mana banyak kematian tersebut disebabkan oleh komplikasi obstetri dan neonatal yang sebenarnya dapat dicegah melalui penanganan yang cepat dan tepat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, penyebab utama kematian ibu antara lain perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, serta komplikasi persalinan, sementara kematian neonatal sering terjadi akibat asfiksia, infeksi, dan bayi berat lahir rendah (BBLR).

Untuk menurunkan AKI dan AKN, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengembangkan Layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) sebagai upaya memperkuat sistem rujukan maternal dan neonatal. PONEK merupakan layanan terpadu di rumah sakit yang menyediakan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal 24 jam dengan tenaga kesehatan terlatih, fasilitas memadai, serta standar prosedur yang jelas. Implementasi layanan PONEK secara optimal diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Rumah Sakit Prima Husada adalah sebuah Rumah Sakit Swasta tipe C yang terletak di Banjararum Selatan, Singosari, Malang. Rumah sakit berperan sebagai ujung tombak dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan juga berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas kesehatan maternal-neonatal di Indonesia dan mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Demi terselenggaranya keberhasilan PONEK diperlukan dukungan berbagai aspek krusial yang saling terkait, mulai dari penyediaan sumber daya manusia hingga penguatan sistem rujukan.

Pertama, rumah sakit menyiapkan tim medis khusus yang terdiri dari dokter spesialis obstetri-ginekologi, dokter anak, dokter anestesi, dan tenaga bedah, perawat dan bidan yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Kompetensi tim ini terus dijaga melalui program pelatihan berkala dan simulasi kasus gawat darurat. Infrastruktur menjadi pilar penting lainnya. Rumah sakit menyediakan ruang PONEK yang beroperasi 24 jam, dilengkapi dengan ruang bersalin, ruang operasi cesar, serta ruang perawatan intensif untuk ibu (PICU) dan bayi baru lahir (NICU). Kelengkapan alat medis, Laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan cepat dan bank darah yang siap pakai turut mendukung kesiapan penanganan kasus emergensi. Sistem rujukan yang efektif

dibangun melalui kerja sama erat dengan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan klinik.

Protokol klinis yang jelas menjadi panduan tim medis dalam menangani berbagai komplikasi. Rumah sakit menyusun standar operasional prosedur untuk menangani perdarahan, eklampsia, sepsis, dan distosia persalinan, termasuk alur cepat untuk pasien kritis. Audit maternal-perinatal secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kualitas layanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dukungan administratif dan pendanaan menjadi tulang punggung operasional PONEK. Rumah sakit mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan SDM, pemeliharaan alat, dan penyediaan obat-obatan emergensi.

Laporan bulanan ponek dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran pelayanan PONEK yang ada di RS Prima Husada Malang.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan layanan PONEK di Rumah Sakit harus berlandaskan peraturan dan undang undang yang berlaku, diantaranya :

1. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 126 dan 127**
2. Permenkes No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal: Undang- Undang dasar Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi:
3. Permenkes No. 3 Tahun 2022 tentang Standar Profesi Bidan:
4. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Penyelenggaraan PONEK:
5. Pedoman Nasional PONEK Kemenkes: Dokumen teknis yang berisi panduan pelaksanaan PONEK di fasilitas kesehatan
6. Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014: Layanan PONEK termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang harus disediakan rumah sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan serta mengutamakan keselamatan pasien.

1.3.2 Tujuan

1. Memberikan informasi pelayanan PONEK
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan PONEK
3. Menetapkan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan pasien dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 Motto

Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

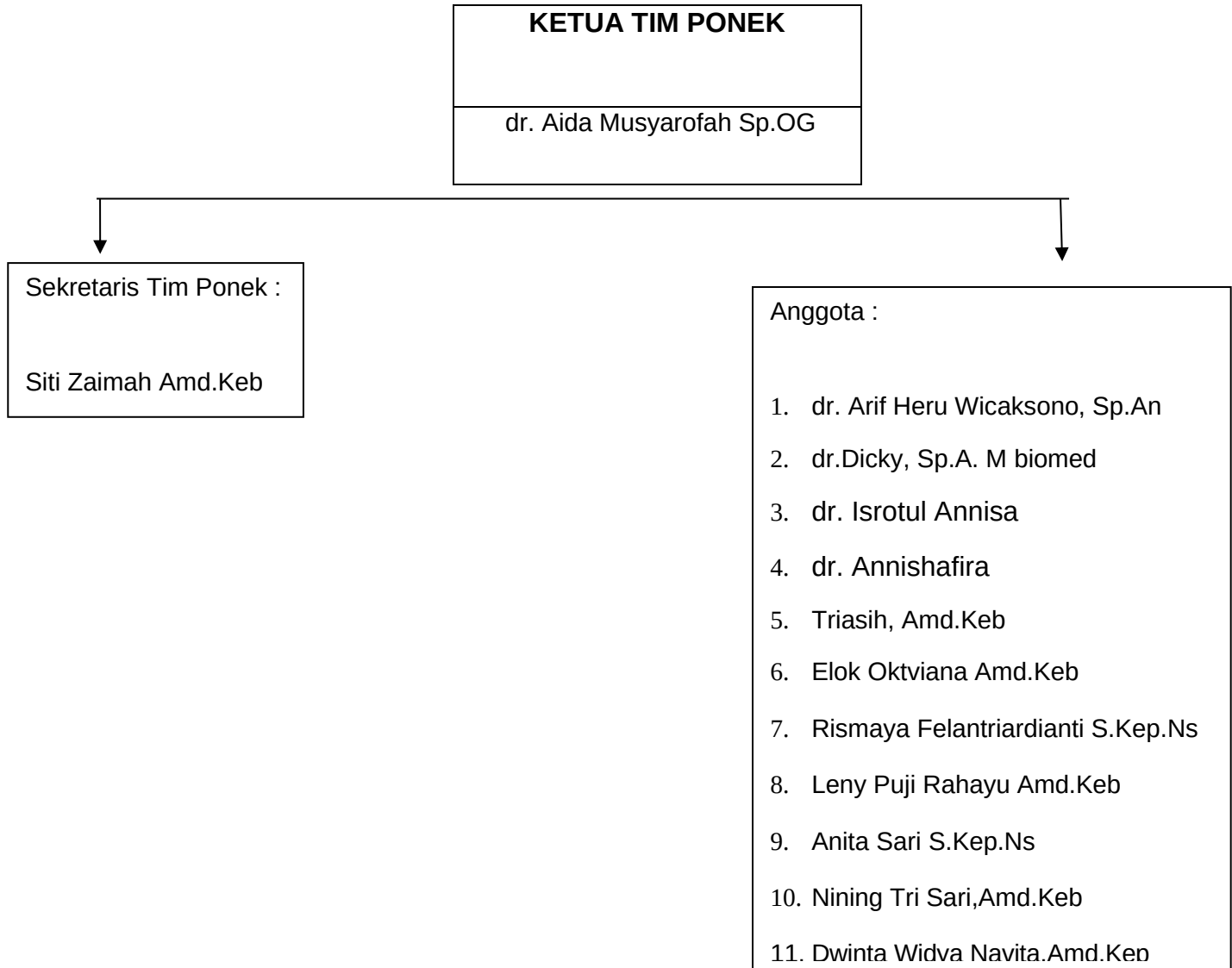
Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adii
7. Peduli

2.5 SOTK



STRUKTUR ORGANISASI TIM PONEK
RS PRIMA HUSADA MALANG



Analiasa	- Jumlah Tim PONEK secara keseluruhan adalah berjumlah 11 orang. Masing - masing anggota memegang jabatan yang berbeda. - Program rotasi: Program rotasi tim PONEK berlaku bila kinerja anggota tidak memenuhi standart tim PONEK dan bila ada anggota yang resign. Pada bulan Oktober tidak ada pergantian anggota Tim PONEK
Rencana Tindak lanjut	Koordinasi dengan Tim PONEK untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan pelatihan inhouse training dan Drill Emergency terkait kegawat daruratan maternal Neonatal.

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Pola Ketenagaan

3.1.1 Jumlah SDM

Tabel 3.1.1 Jumlah SDM Tim Ponek RSPHM bulan Oktober 2025

Jabatan	Jumlah SDM				Ket.
	Standar	Agustus 2025	September 2025	Oktober 2025	
Ketua Tim Ponek	1	1	1	1	
Sekretaris Tim Ponek	1	1	1	1	
Anggota Tim Ponek	11	11	11	11	

3.1.2 Pemenuhan kualifikasi SDM

Tabel 3.1.2 Kualifikasi SDM RSPHM Tim Ponek RSPH Oktober 2025

Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi	
	Standar	Ponek (Wajib)	PPGDON (Wajib)
Ketua Tim Ponek : dr. Aida Musyarofah Sp.OG	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
Sekretaris Tim Ponek : Siti Zaimah Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
1. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp.An	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
2. dr. Dicky, Sp.A M biomed	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
3. dr. Isrotul Annisa	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
4. dr. Annishafira	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
5. Triasih, Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
6. Elok Oktviana Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
7. Rismaya Felantriardianti S.Kep.Ns	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
8. Leny Puji Rahayu Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
9. Dwinta Widya Navita,Amd.Kep	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan

3.1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan Oktober 2025

Tabel 1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan Oktober 2025

NO	Tema DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	JUMLAH PESERTA		TGL Pelak sanaan	Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
			Hadir	Tidak Hadir		
	-					

3.2. Fasilitas PONEK

Tabel 3.2. Fasilitas Ponek RSPHM bulan Oktober 2025

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	USG Transport	Ruang tindakan	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
2	USG 4D	Poli kandungan	1	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 4/09/2025
3	IUD SET	Poli kandungan Ruang tindakan	2 set 2 set	Baik Siap Pakai	
4	Inkubator	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
5	Cuvis	Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	
6	Monitor ECG	Ruang tindakan	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 2/9/2025
7	Box bayi	Perinatologi	15 unit	Baik Siap Pakai	
8	Fototerapi	Perinatologi	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
9	Suction bayi	Ruang tindakan/ IKO	1 set 1 set	Baik Siap Pakai	
10	Partus Set	Ruang tindakan	7 set	Baik Siap Pakai	
11	Curetage set	Ruang tindakan	4 set	Baik Siap Pakai	
12	Vacum manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
13	Timbangan bayi	Ruang tindakan, NICU, PONEK	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
14	NST/CTG	Ruang tindakan, PONEK	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/9/2025
15	Dopler	Ruang tindakan IGD Ponek	2 unit 1 Unit	2 unit baik 1 Unit	Kalibrasi 8/09/2025
16	Infarm warmer	Ruang tindakan. IKO IGD ponek	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 3/9/2025
17	Forsep	IKO	1 set	Baik Siap Pakai	
18	C-PAP Mesin	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
19	Vakum set manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
20	AmbuBag Bayi	Ruang tindakan	3 set	Baik Siap Pakai	
21	Ambubag Dewasa	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
22	Larigoskop bayi dan anak	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
23	Oxymetri neonates	Ruang perinatologi	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
24	Pulse oksimetri neonates baru	Ruang Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
25	Sendok kuret makro no 8 dan 10	Ruang Tindakan	2 unit	Baik siap pakai	
26	Micro curret	Ruang Tindakan	1 unit	Baik siap pakai	
27	Sendok Curret	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
28	HPP set	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
29	Busi kecil	Ruang Tindakan	2 set	Baik siap pakai	
30	Busi besar	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
31	Spekulum besar	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
32	Spekulum sedang	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
33	Spekulum kecil	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
34	Nalfuder No 20	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik Siap pakai	
35	Inkubator transport	Ruang Perinatologi	1 Unit	Baik Siap pakai	Kalibrasi 8/09/2025

Analisa	1) Secara umum kondisi fasilitas dan peralatan PONEK cukup lengkap, Khusus alat penunjang medis yang elektrik sudah terkalibrasi 2) Secara bertahap fasilitas alat PONEK mulai di perbaharui dan alat yang belum tersedia sesuai perencanaan dalam RKA 2025 3) Untuk alat yang rusak, kerjasama perbaikan oleh tim IPSRS 4) Pada bulan Oktober tidak ada jadwal kalibrasi
Rencana Tindak lanjut	1) Melakukan pengecekan alat setiap 1 bulan sekali oleh PJ alat di supervise oleh karu 2) Melakukan pemeliharaan alat secara berkala setiap 1 bulan sekali oleh IPSRS 3) Melakukan kalibrasi setiap 1 tahun sekali

3.3 Kinerja Produktivitas

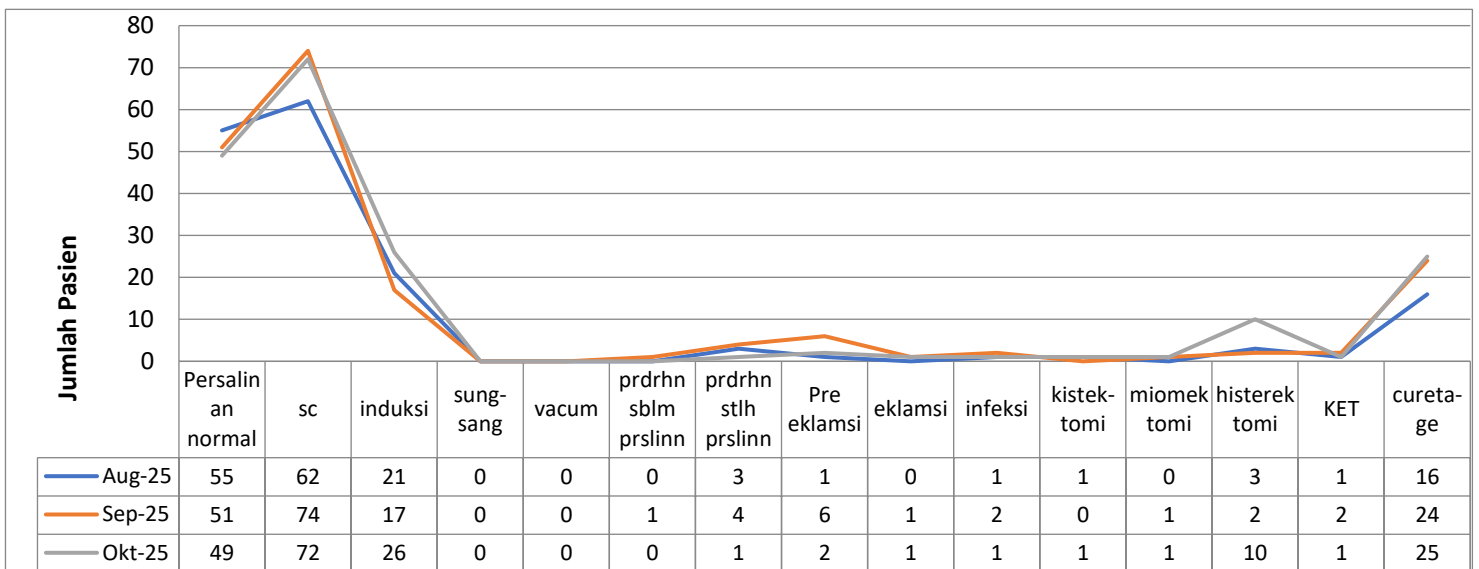
3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

Tabel 3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek RSPHM Oktober 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	55	51	49
	b. <i>SectioCaesaria</i>	62	74	72
2				
	a. Induksi / Drip	21	17	26
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	1	0

	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	4	1
	c. Pre Eklamsi	1	6	2
	d. Eklamsi	0	1	1
	e. Infeksi	1	2	1
4				
	a. Curretage	16	24	25
	b. Kistektomi	1	0	1
	c. Miomektomi	0	1	1
	d. Histerectomy	3	2	10
	e. KET	1	2	1

Grafik 3.3.1
Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi :

- 1) Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Oktober 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 72 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan Oktober 2025 juga sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 49 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu. Jumlah persalinan secara SC dan Persalinan normal pada bulan Oktober sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah pasien INC di maternitas juga sedikit menurun pada bulan Oktober 2025.

- 2) Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
- 3) Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Oktober 2025 dan 2 bulan sebelumnya. Dan juga tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Oktober 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
- 4) Induksi Persalinan pada bulan Oktober mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 26 pasien
- 5) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien. Dan ada 1 kejadian eklamsi pada bulan Oktober 2025.
- 6) Jenis pelayanan curretage di bulan Oktober 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 25 pasien. *Curretage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.3.2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

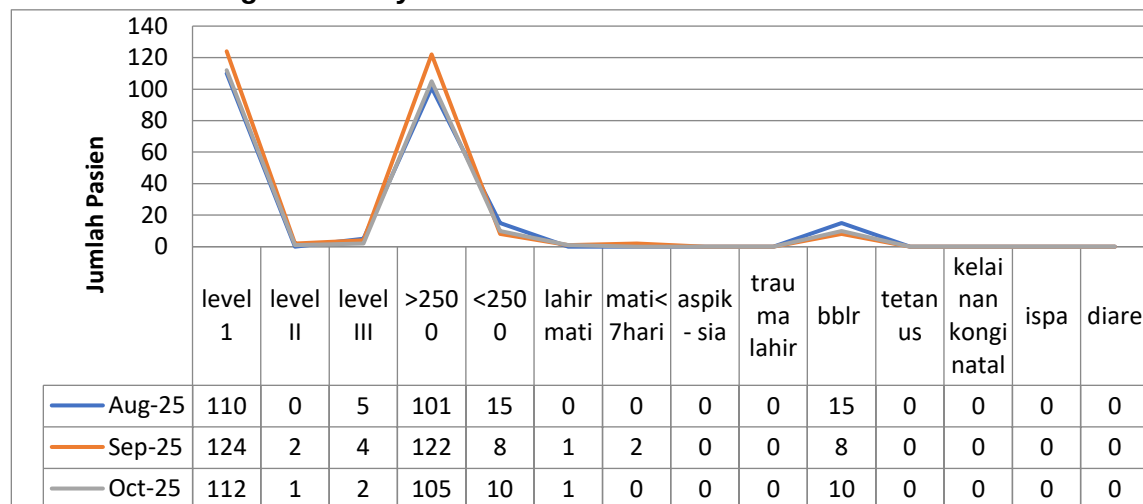
Tabel 3.3.2 tabel jumlah kegiatan pelayanan neonatal Ponpek RSPHM Oktober 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1				
	f. Level 1	110	124	112
	g. Level II	0	2	1
	h. Level III	5	4	2
2				
	a. ≥ 2500 gram	101	122	105

	b. ≤ 2500 gram	15	8	10
3				
	a. Kelahiran Mati	0	1	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	0	1	0
4				
	a. Asphyxia	0	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	15	8	10
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

Grafik 3.3.2

Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

- 1) Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 112 bayi. Dan untuk pelayanan level 2 pada bulan September sebanyak 1 bayi, sedangkan pada level 3 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi. Jumlah bayi bulan Oktober 2025 menurun seiring dengan jumlah persalinan pada bulan Oktober 2025
- 2) Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 105 bayi.
- 3) Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Oktober 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

- 4) Kasus BBLR pada bulan Oktober 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 10 bayi.
- 5) Ada 1 kasus kelahiran mati pada bulan September dan Oktober 2025, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada kasus.
- 6) Tidak ada 2 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan September ada 2 kasus, dan Agustus tidak ada kasus.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3) Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

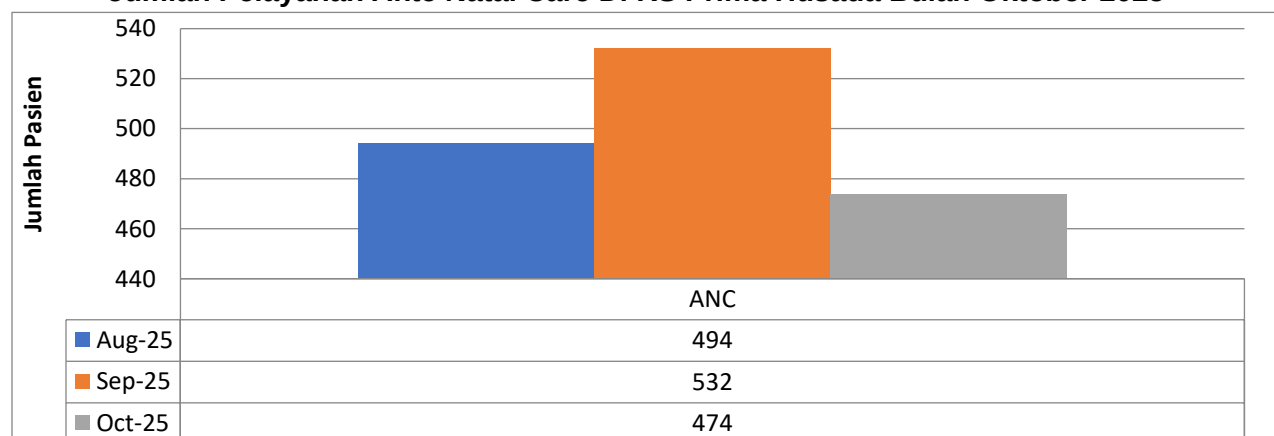
3.3.3. Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel 3.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek RSPHM Oktober 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	ANC	494	532	474

Grafik 3.3.3

Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

Pelayanan ANC pada bulan Oktober 2025 mengalami penurunan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 474 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

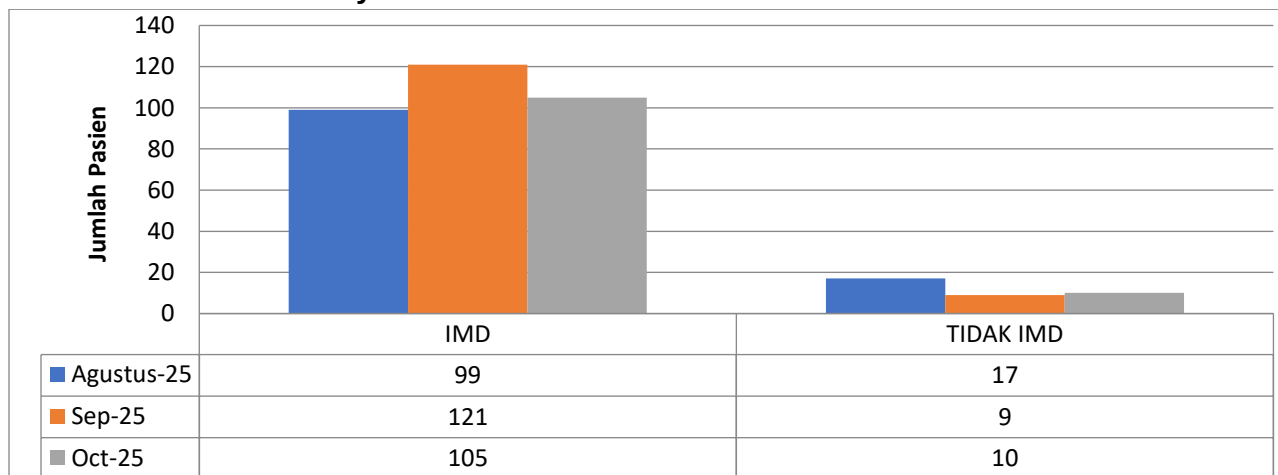
3.3.4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel 3.3.4 Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Oktober 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	IMD	99	121	105
2	Tidak IMD	17	9	10

Grafik 3.3.4

Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

- 1) Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 105 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2) Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Oktober sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi, Sedangkan pada bulan September sebanyak 9 bayi, dan Agustus sebanyak 17 bayi.
- 3) Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Oktober 2025

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Dwi Rahmasari	NCB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Rifka	NCB + BBLR	Cuvis
3	By Ny Salsa	NCB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Ulfi Nur	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Maulidiah	NCB + BBLR	Cuvis
6	By Ny Nurdiana	NKB + BBLR	Cuvis
7	By Ny Anis	NCB + BBLR	Cuvis
8	By Ny Sri Puji	NKB + BBLR	Cuvis
9	By Ny Siti Nabila	NKB + BBLR	CPEP + Inkubator
10	By Ny Juariyah	RDS, BBLR,IUGR	CPEP + Inkubator

- 4) Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

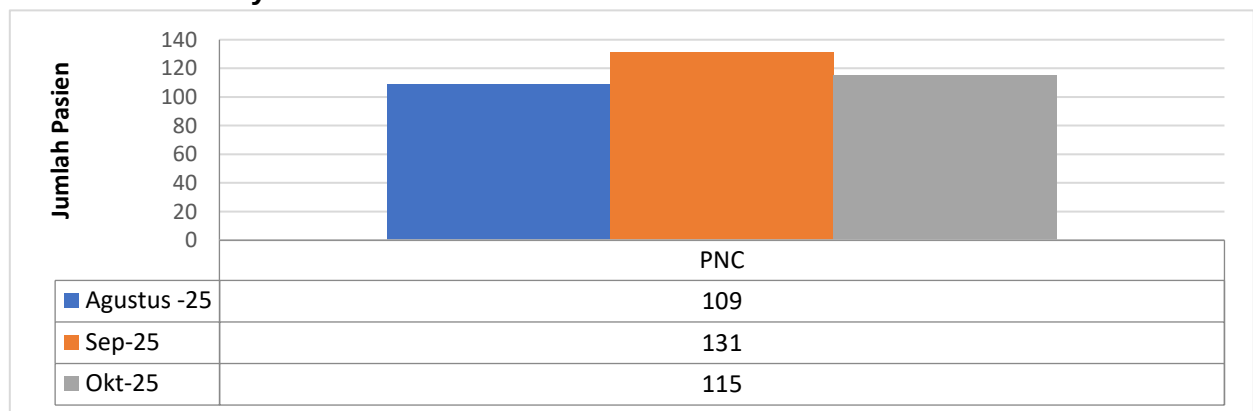
3.3.5. Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel 3.3.5 Pelayanan Post Natal (PNC) Ponpek RSPHM Oktober 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	PNC	109	131	115

Grafik 3.3.5

Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

Pelayanan PNC pada bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 115 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

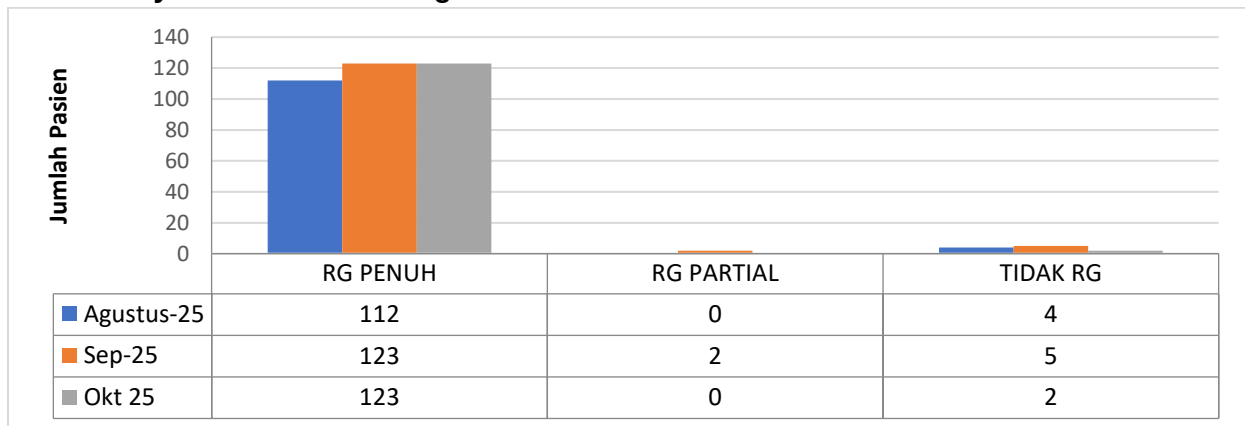
3.3.6. Pelayanan Rawat Gabung

Tabel 3.6 Pelayanan Rawat Gabung Ponek RSPHM Oktober 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	Rawat gabung penuh	112	123	123
2	Rawat gabung partial	0	2	0
3	Tidak Rawat gabung	4	5	2

Grafik 3.3.6

Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

- 1) Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan September dan Oktober 2025 sama yaitu sebanyak 123 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Oktober 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi.
- 3) Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
----	------	----------	---------------

1	By Ny Juariyah	NKB + BBLR	CPEP + Inkubator
2	Ny Ny Siti Nabila	NKB + BBLR	CPEP + Inkubator

- 4) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan skrening awal untuk bayi yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

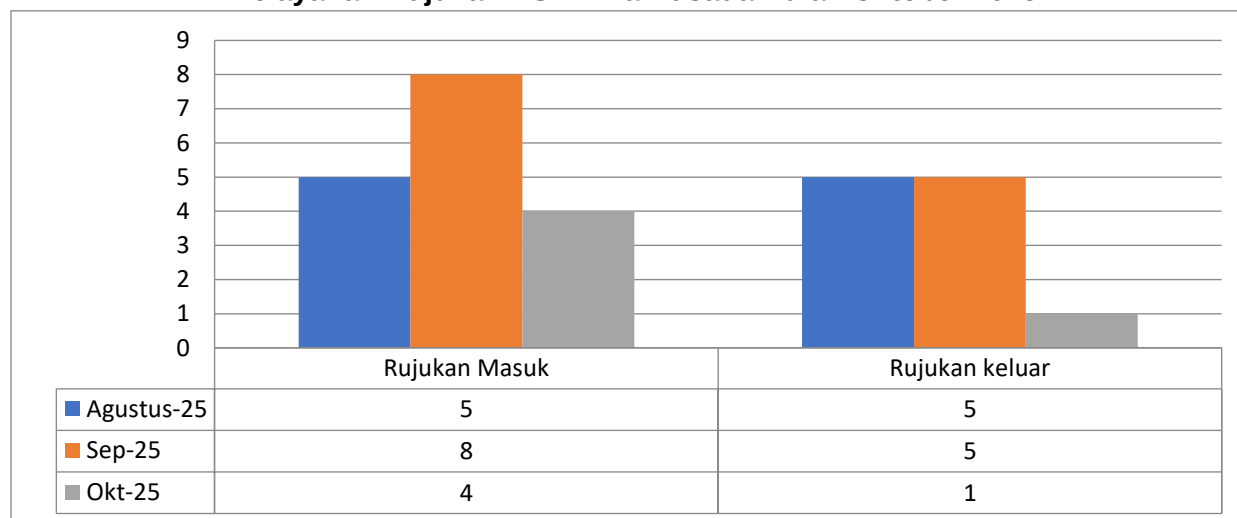
3.3.7. Pelayanan Rujukan

Tabel 3.3.7 Pelayanan Rujukan Ponek RSPHM Oktober 2025

No	Rujukan	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	Rujukan Masuk	5	8	4
2	Rujukan keluar	5	5	1

Grafik 3.3.7

Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Oktober 2025

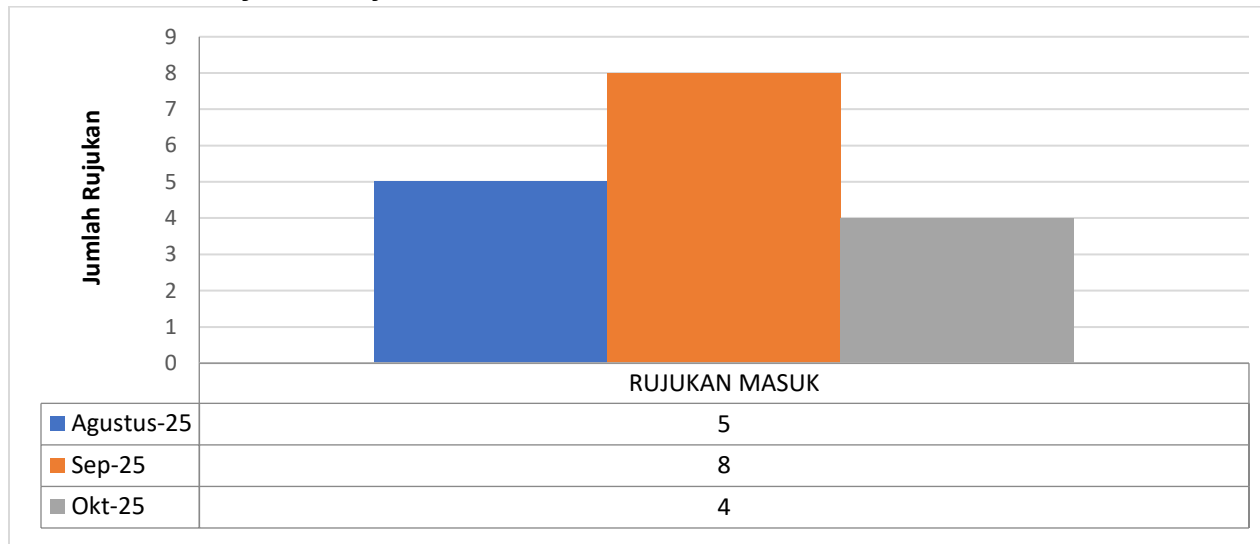


3.3.7.1 Rujukan Masuk

Tabel 3.3.7.1 Rujukan Masuk Ponpek RSPHM Oktober 2025

Bulan Agustus 2025			
1	By Ny Nur Fitri	RDS	PMB Tri W
2	Ny. Illa Rodhiyah	G4 P1103 AB100 UK 10-12 Mgg dg Abortus Inkomplit	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Siska A	G1 P0000 AB 0 UK 32-34 MGG dg kala 2	PKM Singosari
4	Ny Siti Nur H	G1P000 AB00 UK 39-40 Mgg dg kala 2	PKM Lawang
5	Ny Widya A	G1 P0000 AB000 UK 32-34 Mgg dg PPR0M	Klinik Mutiara Sehat
Bulan September 2025			
1	By Ny Sri bawon 1	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
2	By Ny Sri bawon 2	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
3	By By Erwin	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	PKM Singosari
4	By Rayyan Maulana	PNEUMONIA, NEC, BBLSR	RS Sahabat
5	Ny Erwin	P2103 Ab000 dengan post partum + HPP ec sisa plasenta	PKM Singosari
6	Ny Meila	G3 P0010 Ab100 UK 36-37 mgg dg HT+ DM+BOH	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Nur Halimatus	G1 P0000 Ab000 UK 39-40 mgg dg KPD	PMB Titik Sunaryati
8	Ny Cholis Ambiyah	G2 P1001 Ab000 UK 40-41 mgg dengan PEB +KPD	PKM Singosari
Bulan Oktober 2025			
1	Ny Riska Rismawati	G2 P1001 Ab000 UK 32-34 minggu dengan hemoroid	RS Graha Medika
2	Ny mAuludiya	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan kala 2 lama	PMB Indah M
3	Ny Rosa Dwi	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Tuminah	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 minggu dengan prolong KIFA +HT+KPD	RKM Ardimulyo

Grafik 3.3.7.1
Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi :

- 1) Jumlah rujukan masuk pada bulan Oktober menurun yaitu 4 rujukan, sedangkan pada bulan September sebanyak 8, dan Agustus sebanyak 5 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.

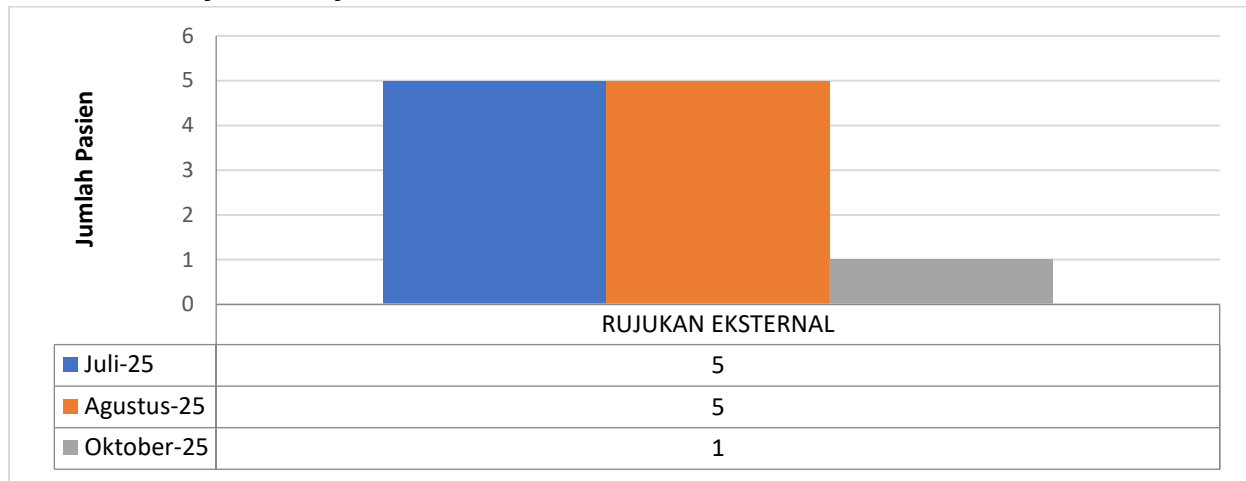
3.3.7.2 Rujukan Keluar

Tabel 3.3.7.2 Rujukan Keluar Ponpek RSPHM Oktober 2025

No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan Agustus 2025						
1	Riyanti	41 Th	Maternitas	P2103 Ab000 dg Post SC+MOW hari ke 2 a/I Inpending eklamsi + anuria	Pro Hemodialisa	RS Saiful Anwar
2	Nn Nafisa	17 Th	Irna 5C	Susp Internal bleeding ec KET + trombositopenia + anemia	Pro Laparatomy cito dg backup transfusi TC	RS Saiful Anwar
3	By Ny Wikke	1 hr	NICU	NKB + BBLR	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny Nur Aini	2 hr	NICU	NCB + Pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette

5	By Ny Nur Fitri	3 hr	NICU	RDS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan September 2025						
1	By Ny Apsah	3 hr	NICU	Bronchopneumonia + Hipoglikemia refrakter	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
2	By Ny Lia	3 hari	NICU	NP-Spt + BBLASR + obs. dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
3	By Ny Erwin	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Soepraoen
4	By Ny Sri bawon 2	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	Ny Lilis	38 th	PONEK	G2 P0000 AB100 UK 30-32 mgg dengan Eklamsi + HT emergency + nprimi tua sprimer + riwayat infertile +HSVB	Penanganan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
Bulan Oktober 2025						
1	Nilam larasati	28 th	PONEK	G2 p1001 ab0 uk 26-28 minggu dg pprom, hiperbilirubin	Penanganan lebih lanjut	RS Saiful Anwar

Grafik 3.7.2
Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi :

Jumlah rujukan keluar pada bulan Oktober menurun yaitu 1 rujukan, sedangkan pada bulan September dan Agustus sebanyak 5 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

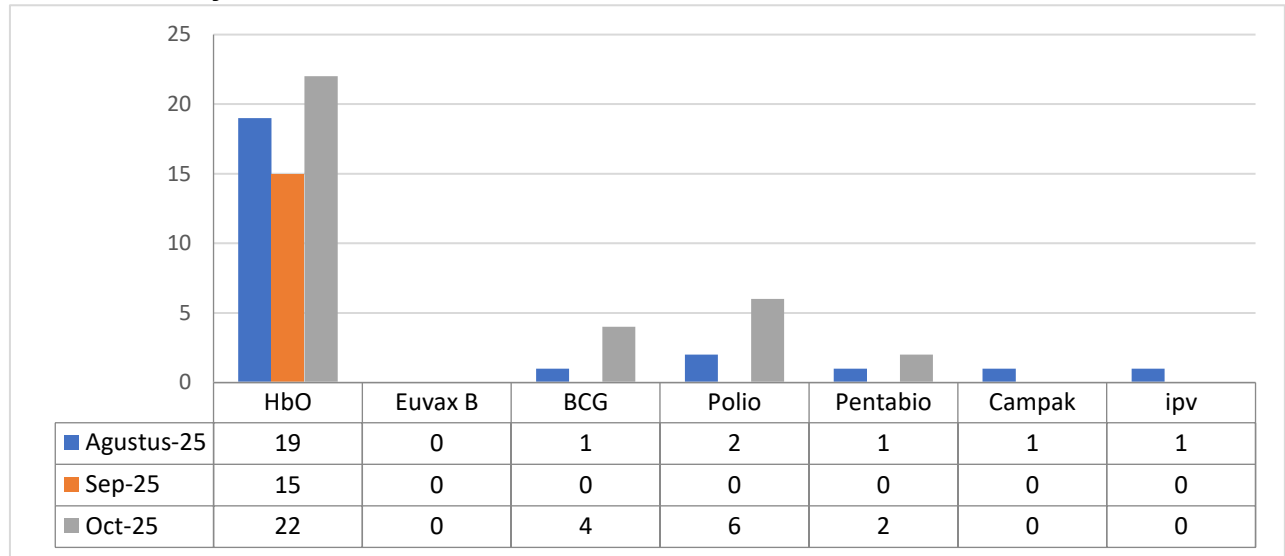
Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.3.8. Pelayanan Imunisasi

Tabel 3.3.8 Pelayanan Imunisasi Ponek RSPHM Oktober 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	HbO	19	15	22
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	0	4
3	Polio	2	0	6
4	Pentabio	1	0	2
5	Campak	1	0	0
6	IPV	1	0	0

Grafik 3.3.8
Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

- 1) Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Oktober 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
- 2) Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Oktober sebanyak 22 bayi, sedangkan pada bulan September Sebanyak 15 bayi, dan Agustus sebanyak 19 bayi. Hal ini dikarenakan minimnya ketidakterseediaanya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 3) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Oktober dan September, sedangkan bulan Agustus sebanyak 1 bayi.
- 4) Ada 4 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan September tidak ada, dan Agustus sebanyak 1 bayi.
- 5) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Campak pda bulan Oktober dan September, sedangkan bulan Agustus sebanyak 1 bayi.
- 6) Ada 6 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Oktober, sedangkan bulan September dan agustus tidak ada
- 7) Ada 2 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan September tidak ada, dan pada bulan Agustus sebanyak 1 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2) Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

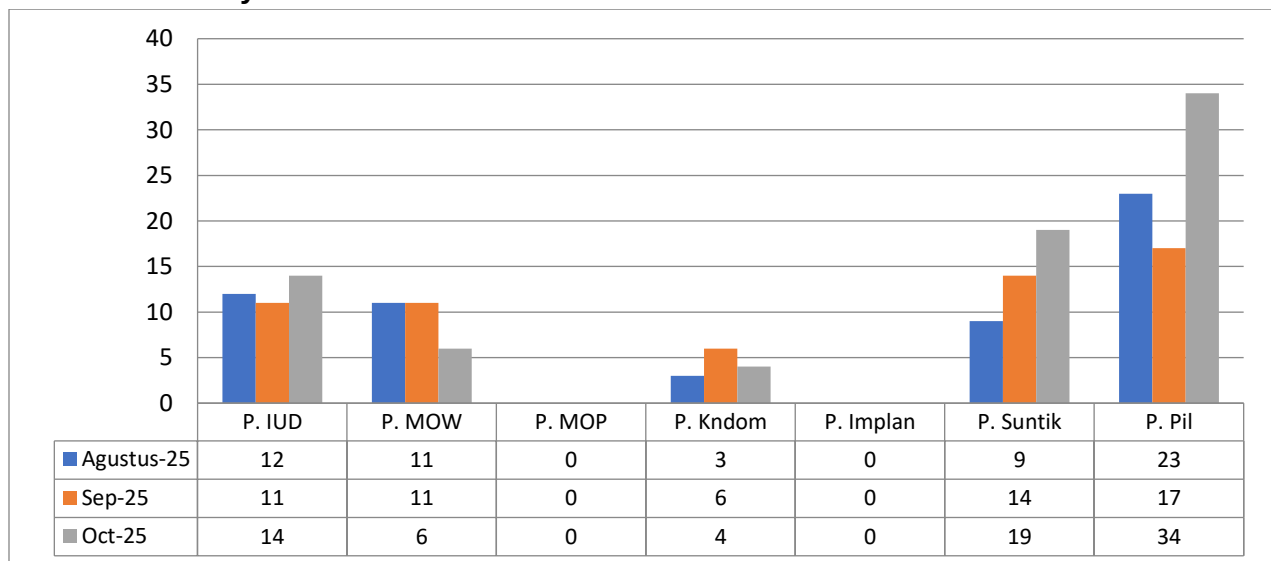
3.3.9. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Tabel 3.3.9.1 Pelayan Pemasangan Keluarga berencana (KB) Ponpek RSPHM Oktober 2025

No	Jenis	Jumlah Pasang		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	IUD	12	11	14
2	MOW	11	11	6
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	3	6	4
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	9	14	19
7	Pil	23	17	34

Grafik 3.3.9.1

Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

- 1) Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Oktober 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 14 akseptor yang terdiri dari 11 akseptor IUD Nova T dan 3 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2) Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Oktober 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 pasien, sedangkan pada bulan September dan Agustus sebanyak 11 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3) Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Oktober menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu yaitu 4, sedangkan pada bulan September sebanyak 6 pengguna, dan Agustus 3 pengguna.
- 4) Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Oktober meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 34 pengguna, sedangkan pada bulan September sebanyak 17 pengguna, dan bulan Agustus sebanyak 23 pengguna.
- 5) Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Oktober sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 19 pengguna, sedangkan bulan September sebanyak 14 pengguna, dan bulan Agustus sebanyak 9 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut

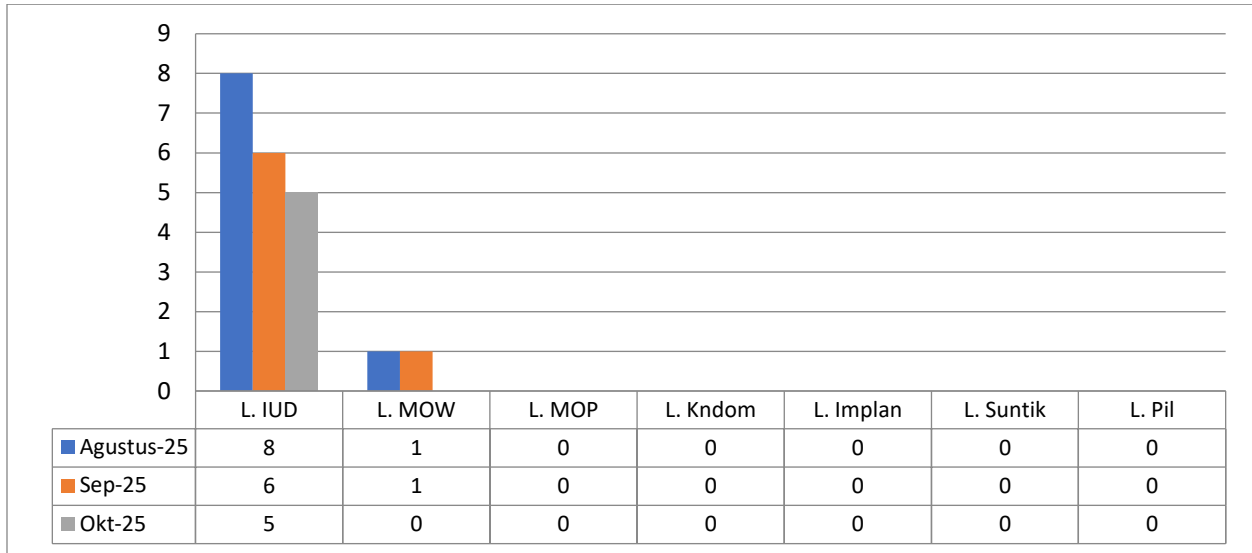
- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3.9.2 Pelayanan Pelepasan Keluarga Berencana (KB)

Tabel 3.3.9.2 Pelayan Pelepasan Keluarga berencana (KB) Ponok RSPHM Oktober 2025

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		Agustus 2025	September 2025	Oktober 2025
1	IUD	8	6	5
2	MOW	1	1	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Grafik 3.3.9.2
Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

1. Pelepasan KB IUD pada bulan Oktober menurun yaitu 5 Akseptor, sedangkan pada bulan September 6 Akseptor , dan Agustus sebanyak 8 akseptor.
2. Pelepasan KB Implan pada bulan Oktober dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut

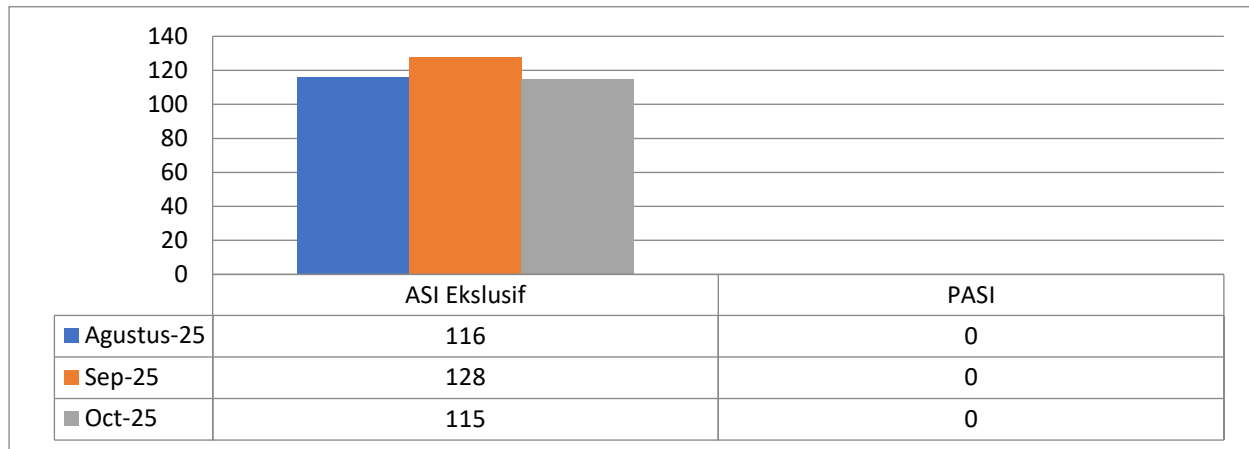
- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3.10. Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 3.3.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponek RSPHM Oktober 2025

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	Asi eksklusif	116	128	115
2	PASI	0	0	0

Grafik 3.3.10
Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

- 1) Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Oktober menurun yaitu 115 bayi, sedangkan pada bulan September sebanyak 128 bayi, dan pada bulan Agustus sebanyak 116 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2) Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan Oktober dan 2 bulan sebelumnya. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut

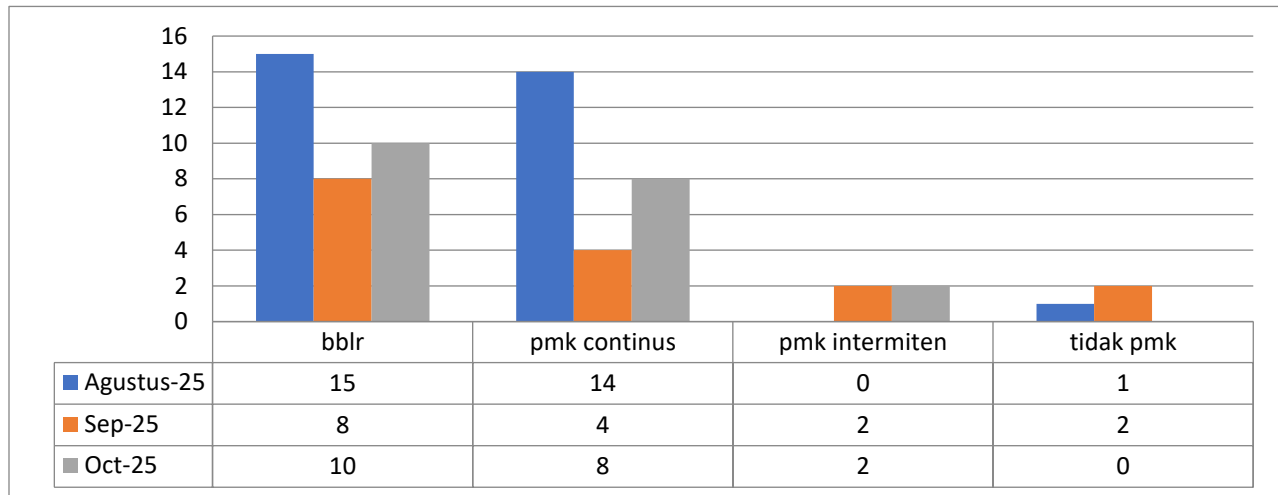
- 1) Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.3.11. Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel 3.3.11 Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponok RSPHM Bulan Oktober 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	Bayi BBLR	15	8	10
2	PMK continuos	14	4	8
3	PMK Intermiten	0	2	2
4	Tidak PMK	1	2	0

Grafik 3.3.11
Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi

- 1) Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2) Ada 2 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Oktober dan September, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
- 3) Sedangkan metode PMK continus pada bulan Oktober meningkat yaitu 8 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil, sedangkan pada bulan September sebanyak 4 bayi, dan Agustus 2025 sebanyak 14 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada.
- 4) Tidak ada bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Oktober, sedangkan pada bulan September sebanyak 2 bayi, bulan Agustus ada 1 bayi.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

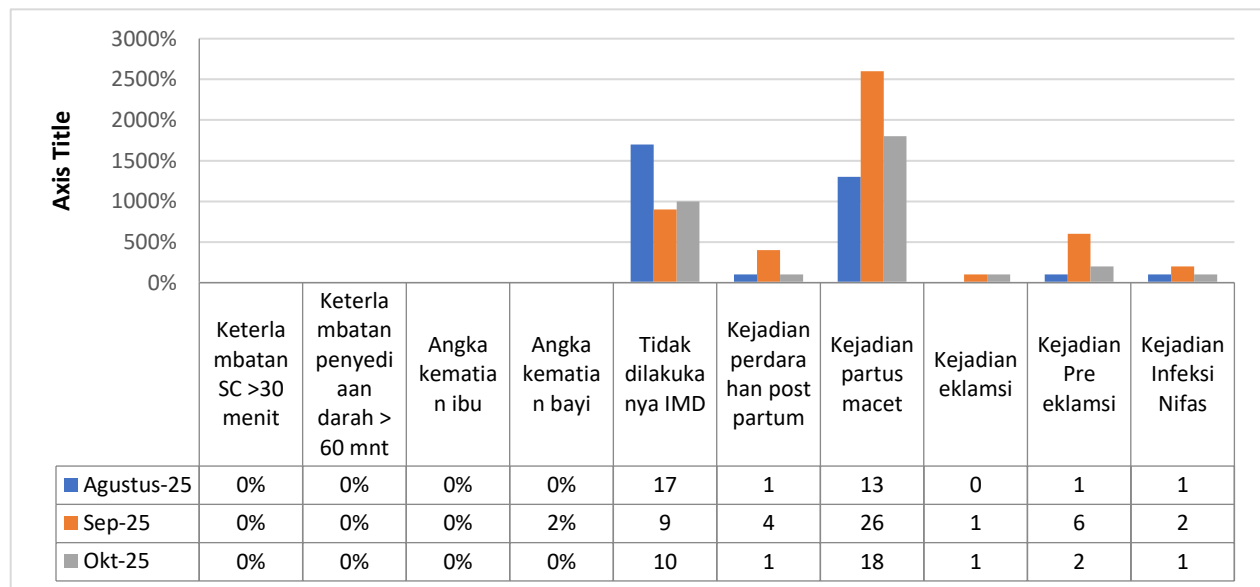
3.4 MUTU

Tabel 3.4 MUTU Ponek RSPHM Mutu bulan Oktober 2025

No	Pengukuran Mutu	Standart	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025	Bulan Oktober 2025
1	Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) >30 menit	0%	0%	0%	0%
2	Angka keterlambatan penyediaan darah (> 60 menit)	<10%	0%	0%	0%
3	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%
4	Angka kematian bayi	0%	0 %	2%	0%
5	Kejadian tidak dilakukanya IMD (Inisiasi Menyusui Dini) pada bayi baru lahir	0	17	9	10
6	Kejadian perdarahan post partum	0	1	4	1
7	Kejadian partus macet	0	13	26	18
8	Kejadian eklamsi	0	0	1	1
9	Kejadian Pre eklamsi	0	1	6	2
10	Kejadian Infeksi Nifas	0	1	2	1

Grafik 3.4

Mutu PONEK Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi :

- 1) Pada Mutu Angka kematian Ibu pada bulan Oktober 2025 maupun 2 bulan sebelumnya sebanyak 0 %. Hal ini dikarenakan tidak ada kejadian kematian pada maternal pada bulan tersebut.
- 2) Pada Mutu Angka kematian Bayi pada bulan Oktober dan Agustus 0 %, sedangkan pada bulan September sebanyak 2 %, Hal ini dikarenakan tidak ada kasus kematian pada Neonatal pada bulan Oktober
- 3) Pada mutu tidak dilakukannya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir, Pada bulan Oktober sebanyak 10 bayi, sedangkan bulan September sebanyak 9 bayi Agustus sebanyak 17 bayi.
- 4) Berikut alasan kenapa bayi tidak dilakukannya IMD pada bulan Oktober 2025

No	Nama	Diagnosa	Perawatan
1	By Ny Dwi Rahmasari	NCB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Rifka	NCB + BBLR	Cuvis
3	By Ny Salsa	NCB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Ulfi Nur	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Maulidiah	NCB + BBLR	Cuvis
6	By Ny Nurdiana	NKB + BBLR	Cuvis
7	By Ny Anis	NCB + BBLR	Cuvis
8	By Ny Sri Puji	NKB + BBLR	Cuvis
9	By Ny Siti Nabila	NKB + BBLR	CPEP + Inkubator
10	By Ny Juariyah	RDS, BBLR,IUGR	CPEP + Inkubator

Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir dikarenakan bayi lahir dengan BBLR kurang bulan dan Asfiksia, sehingga bayi memerlukan tindakan segera untuk pemasangan alat bantu CPAP dan perawatan incubator. Oleh karena itu bayi tidak dilakukannya IMD. Perawat bayi melakukan IMD sesuai dengan syarat yang telah ditentukan kecuali pada bayi dengan kondisi asfiksia sedang-berat dan kelainan konginetal, pada TM III terjadi peningkatan pada kasus ini, bayi tidak di IMD yang disebabkan karena BBLR dan asfiksia sedang-berat yang membutuhkan perawatan incubator, C-pap dan oksigen.

- 5) Pada kasus pasien pre eklamsi pada bulan Oktober sebanyak 2 kasus, sedangkan pada bulan September sebanyak 6 kasus, dan bulan Agustus sebanyak 1 kasus. Unit terkait akan berkolaborasi dengan SP.OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi.
- 6) Pada kasus Kejadian partus macet pada bulan Oktober menurun, yaitu sebanyak 18 kasus, sedangkan bulan September sebanyak 26 kasus, dan Agustus sebanyak 13 kasus. Kejadian partus macet pada bulan Oktober dikarenakan prolong fase laten, prolong fase aktif, dan kala 2 lama, sehingga pasien dilakukannya operasi SC.

- 7) Ada 1 Kejadian perdarahan post partum pada bulan Oktober dan Agustus, sedangkan bulan September sebanyak 4 kasus. Kejadian perdarahan post partum pada bulan Oktober disebabkan karena atonia uteri.
- 8) Ada 1 kejadian Infeksi nifas pada bulan Oktober dan Agustus, sedangkan pada bulan September sebanyak 2 kejadian.

Rencana dan Tindak Lanjut

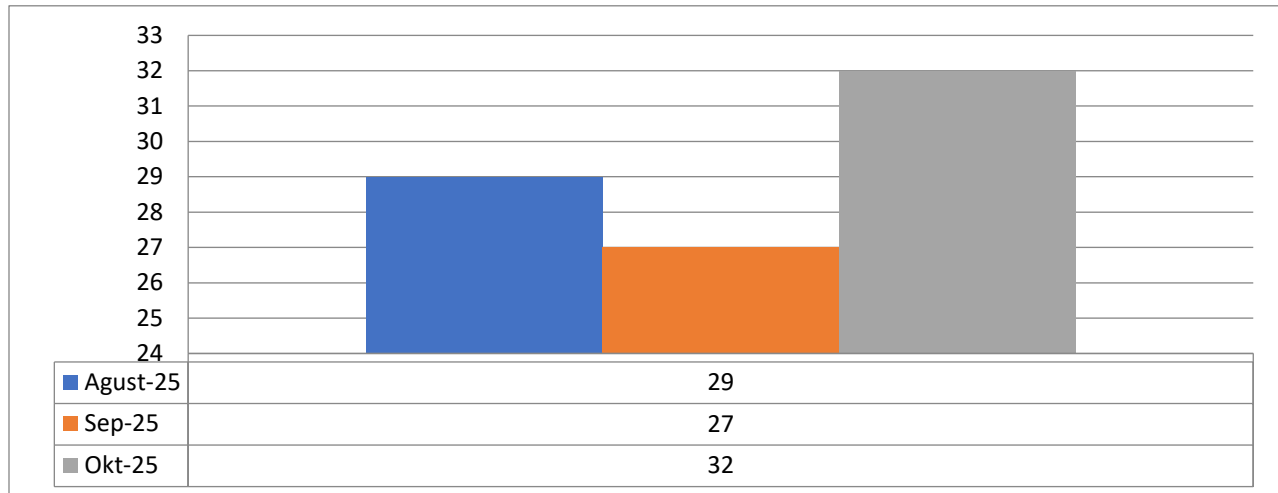
- 1) Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atau tidak.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) berkolaborasi dengan SP. OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi
- 4) Memberikan Edukasi pada Ibu post Nifas terkait gizi yang dibutuhkan ibu Nifas, agar tidak terjadi lagi kasus infeksi pada Ibu nifas.
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah Kunci indikator mutu PONEK.
- 6) Koordinasi dengan Tim PMKP untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.5 Kelas Senam hamil

Tabel 3.5 Kelas senam hamil RSPHM Oktober 2025

Pengembangan Pelayanan	Hasil kinerja	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
Senam Hamil	- Minggu ke 2 : Anggota : 30 peserta Hadir : 13 peserta. - Minggu ke 4 : Anggota: 30 peserta Hadir : 19 peserta .Target : 1 bulan 2 kali. Hasil : 2x/bulan = bumil	- Rata-rata kehadiran bulan Oktober senam hamil 53 % Total persalinan 70% dari senam hamil yang diselenggarakan di PHM, dengan senam hamil ini dapat menambah citra RS yang lebih baik, menambah kunjungan dan semakin banyak orang yg menyukai RS Prima Husada Malang. - Jumlah peserta senam hamil masih belum mencapai target dengan jumlah peserta setiap datang target 30 peserta,.	- Berkolaborasi dengan asisten Poli Obgyn untuk mengedukasi pasien hamil uk diatas 22 minggu untuk mengikuti senam hamil. - KIE bahwa kelas senam terdapat Hypnopregnancy yang akan kontinyus dg hypno melahirkan. - Video Promosi senam hamil yang di tampilkan di IG RS dan di prima menyapa

Grafik 3.5.1
Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2025



Evaluasi :

1. Peserta senam hamil pada bulan Oktober sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 32 peserta, 27 peserta pada bulan September, dan 29 peserta pada bulan Agustus.
2. Peserta senam hamil pada bulan September yang melahirkan 8 pasien, 5 pasien melahirkan di RS Prima Husada, 3 pasien melahirkan di faskes lain.
3. Dari 8 peserta senam hamil yang melahirkan, 8 pasien mengatakan pada proses persalinan senam hamil dan hypnoterapi sangat membantu.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan penjangkaran ibu hamil usia kehamilan 22-24 minggu untuk melakukan senam hamil.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil di ruang tunggu poli untuk melakukan senam hamil
- 3) Berkolaborasi dengan PKRS membuat flayer promosi senam hamil yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn
- 4) Membuat video promosi senam hamil yang di putar di prima menyapa dan di upload di IG RS
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah peserta senam hamil.
- 6) Koordinasi dengan Tim PKRS untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.6 PKRS

Tabel 3.6 PKRS Ponpek RSPHM Bulan Oktober 2025

Kegiatan	Target	Agustus 2025		September 2025		Oktober 2025	
Edukasi kelompok	4x/bl	1. tanda bahaya TM III+ tanda awal proses melahirkan 2. Persiapan senam hamil 3. Persiapan melahirkan 4.ASI eksklusif		1. Persiapan persalinan dengan Teknik persalinan candle blow breath 2. Persiapan senam hamil 3. Senam Hamil 4. Persiapan senam hamil		1. Persiapan senam hamil 2. ASI Eksklusif 3. Pendampi ibu hamil dengan Hypnopregnancy 4. Senam Hamil	
Edukasi individu	100%	1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB		1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB		1. Asi Eksklusif 2. Perawatan Payudara 3. Pijat laktasi 4. IMD 5. Personal Hygiene 6. KB	
Kegiatan	Target	Mei 2025		Oktober 2025			
Pembinaan Jejaring	3x/tahun	1. Kegawatdaruratan Neonatal 2. Evaluasi rujukan		1. Pendampi ibu hamil dengan Hypnopregnancy 2.Evaluasi rujukan			

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Tabel 4. 1. Hasil Monitoring Ponek RSPHM Oktober tahun 2025

No	Bulan	Kegiatan	Jumlah yang dipantau/ diobservasi	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
1	Oktober	Diklat Kegawatan Maternal Neonatal	8	Dari dinas kesehatan diminta dokter umum mempunyai sertifikat kegawatan maternal neonatal	dokter umum di RS prima Husada belum ada yang mempunyai sertifikat kegawatan maternal neonatal	Koordinasi dengan SDM dan Kabid pelayanan Medis	SDM	

4.2.Evaluasi

Tabel 4.2. 1 Hasil evaluasi Ponек 2025

Bulan	Masalah yg dibahas	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
Oktober	Pelayanan Imunisasi	Bayi baru lahir tidak mendapatkan imunisasi HB0	1.Vaksin Hb0 di puskesmas terbatas, bulan Oktober bayi baru lahir yang mendapatkan vaksin HB0 yaitu 22 pasien ,sedangkan jumlah kelahiran bulan Oktober 115 bayi. 2.Pasien yang melahirkan di RS Prima Husada tidak hanya dari wilayah singosari melainkan dari luar wilayah Puskesmas singosari	1.Koordinasi dengan Puskesmas Ardimulyo 2. Koordinasi dengan Puskesmas Singosari 3. Koordinasi dengan Kabid yanmed, kepala instansi farmasi, Karu Neonatologi untuk pengadaan vaksin uvax-B	Tutut Dhora	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	IUD pasca lahir	1.Pemasangan IUD pasca lahir dan pasca curet pasien abortus 12 pasien dikarenakan pemasangan IUD berbayar jika dipasang dokter 2.IUD nova T alat+jasa dokter : 850.000	1. Melakukan edukasi pasien inpartu, rencana SC,pasien abortus 2. Edukasi pasien dan penunggu di ruang tunggu poli kandungan oleh PJ KBRS	Ima,Dayu	

			7. IUD coper T alat gratis, ada jasa dokter 400.000 8. Pemasangan IUD coper T oleh bidan gratis 9. Pasien memilih KB setelah nifas	3. Membuat flayer KB yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn		
	Kelas Senam Hamil	Peserta senam hamil belum mencapai target	Kelas senam hamil di Prima Husada dilakukan 2 kali dalam satu bulan minggu ke 2 dan minggu ke 4 dengan target peserta setiap kelas 30 peserta, sehingga 1 bulan 60 peserta, pada bulan Oktober peserta senam hamil 32 orang	1. Memberikan info kepada ibu hamil di poli Obgyn untuk melakukan senam hamil 2. Membagikan Flayer senam hamil di IG RS Prima Husada 3. Membuat video promosi senam hamil yang di share di IG RS dan di prima menyapa 4. Membuat Flayer promosi senam hamil yang di tempatkan di ruang tunggu poli obgyn	Ima,erico ,dayu	

Tabel 4.2.2 Hasil Rekapitulasi Supervisi Bulan Oktober 2025

No.	Komponen yang dinilai	Standar	Dilakukan		Temuan	Tindak Lanjut
			Ya	Tidak		
1	Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan PONEK 24 jam.	PONEK 1 EP 1	√	-	Sudah dilakukan revisi 90% kurang TTD direktur	Melakukan monitoring dan evaluasi
2	Terdapat Tim PONEK yang ditetapkan oleh rumah sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.	PONEK 1 EP 2	√	-	SK Tim Ponek sudah dilakukan revisi 100%	Melakukan monitoring dan evaluasi
3	Terdapat program kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit maksud dan tujuan.	PONEK 1 EP 3	√	-	Sudah dilakukan revisi 90% kurang TTD direktur	Melakukan monitoring dan evaluasi
4	Terdapat bukti pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit	PONEK 1 EP 4	√		Bukti laporan tentang pelaksanaan program PONEK pada Laporan Triwulan PONEK dan sudah di Disposisi Direktur	Melakukan monitoring dan evaluasi
5	Program Ponek Rumah Sakit dipantau dan di evaluasi secara rutin	PONEK 1 EP 5	√		Bukti tentang program PONEK Rumah Sakit dipantau dan dievaluasi secara rutin pada Laporan Triwulan PONEK. pelaksanaan pemberian materi edukasi ke pasien : 1. Imunisasi : Hasil supervisi pelaksanaan Imunisasi HBO 19,3% dari 115 pasien bayi baru lahir. 2. KB : Hasil supervisi pelaksanaan KB 8,7 % dari 122 pasien melahirkan dan 12 pasien abortus 3. IMD : hasil supervisi pelaksanaan IMD 100% dari 74 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien 4. Asi Eksklusif; hasil supervisi 100 % dari 74 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien 5. PMK : hasil supervisi 100% dari 10 pasien yang di observasi, metode yang digunakan wawancara ke pasien	Melakukan monitoring dan evaluasi

				6. Perawatan BBL : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan BBL 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 7. Makan & minum ibu menyusui : hasil supervisi pelaksanaan edukasi makan minum ibu menyusui 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 8. Cek ASI : hasil supervisi pelaksanaan cek ASI 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 9. Rawat gabung: hasil supervisi pelaksanaan rawat gabung 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 10. Menyusui Bayi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi menyusi bayi 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 11. Perawatan Payudara : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan payudara 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 12. Personal Hygine : hasil supervisi pelaksanaan edukasi personal Hygine 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 13. Perawatan luka post sc : hasil supervisi pelaksanaan edukasi perawatan luka post op sc 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien 14. Pijat laktasi : hasil supervisi pelaksanaan edukasi pijat laktasi 100% dari pasien yang di observasi 74 pasien/bulan metode yang digunakan wawancara ke pasien Materi edukasi Tersedia elektronik dan fisik dilengkapi dengan barcode https://drive.google.com/drive/folders/1N CV9Pi0N62 26XenW3XPha -NosZfZid	
--	--	--	--	---	--

6	Rumah sakit menetapkan program pembinaan jejaring rujukan rumah sakit.	Ponek 1.1 EP 1	√			Melakukan monitoring dan evaluasi
7	Rumah sakit melakukan pembinaan terhadap jejaring secara berkala.	Ponek 1.1 EP 2	√		• Senam hamil bulan Oktober dilakukuan 2 kali dalam 1 bulan. • Pembinaan jejaring dilakukan pada bulan mei dan Oktober tahun 2025	Melakukan monitoring dan evaluasi
8	Telah dilakukan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan	Ponek 1.1 EP 3	√		1. Rata-rata kehadiran senam hamil bulan Oktober yaitu 53%. Total persalinan 70% dari senam hamil yang diselenggarakan di PHM. 2. Rujukan masuk bulan Oktober 9 pasien Dari 9 pasien yang dirujuk 9 pasien saat merujuk sudah dilakukan penatalaksanaan awal rujukan, perujuk sudah konfirmasi ke RS dan pasien diantar ke RS 3. Hasil Evaluasi Pembinaan jejaring bulan Oktober 2025 pelayanan keseluruhan rujukan di RS 75,9% menunjukkan prosentasi baik, 23,3% menunjukkan prosentasi sangat baik, dan 0,71% menunjukkan prosentasi kurang baik. 4. Kendala dari perujuk: • 14,2% perujuk mengatakan proses rujukan lama • 2,3% Pengisian google form terlalu ribet dan lama • 2,3% Kesusahan menghubungi IGD 5. Masukan dari perujuk : • Di perbaiki proses rujukannya • Pasien yg dirujuk klo keadaan darurat itu diterima dulu saja biar CPT ditangani dulu mengingat pasien butuh alat yg lebih lengkap daripada di tpmb yg alatny terbatas • Sebaiknya bila kita habis merujuk pasien ada informasi balik yg di berikan ke bidan • Kasus gawat darurat kebidanan di sambungkan link Kamar Barsalin 6. Kepuasan dari perujuk • 16% perujuk menyampaikan Pelayanan cepat • 33 % perujuk menyampaikan Respon dan Pelayanan baik	monitoring dan evaluasi

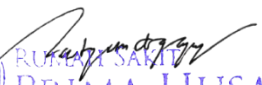
BAB V
PENUTUP

Demikian laporan Ponek bulan Oktober 2025 disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang . Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Ketua Tim PONEK


dr. Aida Musygrofah, Sp. OG

Malang, 3 November 2025
PLT Direktur Rumah Sakit
Prima Husada


 **PRIMA HUSADA**
dr. Resti Lestantini, M. Kes